



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA TIM PKBRS
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Kerja Tim PKBRS

Disusun Oleh

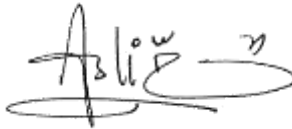
Ketua PKBRS



(dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG)

Disetujui Oleh

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes., AFP)

Ditetapkan Oleh

Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. Kep)

TIM PENYUSUN
PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT

PENGARAH

- 1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
- 2. Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

PENYUSUN

- 1. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG
- 2. Iin Widowati, S.Tr.Keb
- 3. Hanifah Ummu Choir, S.Tr.Keb

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Kerja Tim PKBRS dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Kerja Tim PKBRS ini mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pada pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi Pendidikan kesehatan dalam pelayanan rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja Tim PKBRS mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Pasuruan, 1 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

DAFTAR ISI

JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
TIM PENYUSUN
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
 1.1 Latar Belakang 1
 1.2 Tujuan 2
 1.3 Ruang Lingkup 2
BAB II PENGORGANISASIAN
 2.1 Organisasi tim pkbrs 3
 2.2 Kebijakan 3
 2.3 Struktur Organisasi 3
 2.4 Kualifikasi Ketenagaan 3
 2.5 Uraian Dan Tugas..... 3
BAB III SARANA DAN PRASARANA
 3.1 Sarana 4
 3.2 Peralatan 5
 3.3 Dana 9
BAB IV KEGIATAN DAN TATA LAKSANA
 4.1 Kegiatan Tindakan Pelayanan KB 21
 4.2 Kegiatan Edukasi..... 21
BAB V PELAPORAN
 5.1 Pengertian 22
 5.2 Jenis Laporan 22
BAB VI PENUTUP

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 939.5/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025**

TENTANG

**PEDOMAN KERJA TIM PKBRS
(PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RUMAH SAKIT)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan jumlah kelahiran dan meningkatkan kualitas keluarga di Rumah Sakit Prima Husada, serta pelaksanaan rumah sakit tentang pasangan usia subur, maka perlu adanya Pedoman Kerja Tim PKBRS (Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit) Rumah Sakit Prima Husada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Tim PKBRS (Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit) Rumah Sakit Prima Husada;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan Seksual;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan RS;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 9 Tahun 2020 tentang

-
- Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana;
11. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
 12. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PKBRs**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Keluarga Berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, penjarangan dan penghentian kehamilan dan pengobatan kemandulan yang dilakukan secara sukarela.
- (2) Rumah Sakit adalah semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan.
- (3) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (4) Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas secara optimal;
- (5) Peralatan medis adalah peralatan utama yang harus dimiliki RS untuk dapat melaksanakan pelayanan KB sesuai dengan metode kontrasepsi yang diberikan.
- (6) Peralatan non medis adalah peralatan pendukung yang harus dimiliki oleh RS untuk melaksanakan pelayanan KB.
- (7) Pelayanan Kontrasepsi merupakan upaya kesehatan dengan menggunakan metode tertentu untuk mengatur jarak kehamilan atau menghentikan kehamilan.
- (8) Kontrasepsi mantap suatu tindakan untuk membatasi kelahiran dalam jangka waktu yang tidak terbatas melalui suatu tindakan operasi kecil dengan cara mengikat dan memotong saluran telur pada istri (tubektomi) atau mengikat dan memotong saluran sperma pada suami (vasektomi) atas permintaan yang bersangkutan secara sukarela.
- (9) Pelayanan KB di Rumah Sakit adalah pelayanan medik dan non medik, yang disediakan dan diberikan oleh tenaga

kesehatan yang kompeten sesuai dengan standard dan perkembangan iptek dengan menggunakan fasilitas dan sarana yang memenuhi ketentuan.

- (10) Pelayanan Konseling adalah pelayanan untuk memberikan bantuan kepada klien dalam pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi yang cocok. Dalam memberikan pelayanan ini menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) ber-KB.
- (11) Penapisan Klien suatu prosedur selektif yang sesuai dengan kebutuhan sebelum tindakan medis, antara lain menanyakan identitas, riwayat penyakit dan kehamilan serta melakukan pemeriksaan fisik.
- (12) KB Pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari.
- (13) KB Pasca Keguguran adalah pelayanan KB yang diberikan setelah mengalami keguguran sampai kurun waktu 14 hari;
- (14) Klien adalah salah satu Pasangan Usia Subur (PUS) yang merupakan calon atau peserta KB.
- (15) Alkon Program adalah jenis dan alat metode kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program KB.
- (16) Peserta KB Baru adalah PUS yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau PUS yang kembali menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran.
- (17) Peserta KB Aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2 Tugas, Tanggung, Jawab dan Wewenang

- (1) Rumah Sakit membentuk Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) untuk menjamin terselenggaranya pelayanan keluarga berencana yang terintegrasi, bermutu, berkesinambungan, berorientasi pada keselamatan pasien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Tim PKBRS ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan organisasi Tim PKBRS sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua Tim
 - c. Sekretaris
 - d. Koordinator Pelayanan Medis
 - e. Koordinator Keperawatan dan/atau Kebidanan
 - f. Koordinator Farmasi
 - g. Koordinator Rekam Medis
 - h. Koordinator Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

-
- (4) Keanggotaan Tim PKBRS ditetapkan berdasarkan kompetensi, kewenangan klinis, dan keterlibatan dalam pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi.
 - (5) Tim PKBRS bekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing – masing.

Pasal 3
Tata Hubungan Kerja

- (1) Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) melaksanakan tugas secara koordinatif, integratif, kolaboratif, dan fungsional dengan seluruh unit pelayanan dan unit pendukung di rumah sakit untuk menjamin kesinambungan pelayanan keluarga berencana yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PKBRS bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan berkoordinasi dengan Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Instalasi, Kepala Unit, serta pejabat terkait sesuai struktur organisasi rumah sakit.
- (3) Tim PKBRS menjalin hubungan kerja dengan:
 - a. Instalasi Rawat Jalan dalam pelaksanaan skrining, konseling, pelayanan kontrasepsi, dan tindak lanjut pelayanan keluarga berencana.
 - b. Instalasi Rawat Inap dalam pemberian edukasi, konseling, dan pelayanan KB bagi pasien yang memenuhi kriteria.
 - c. Instalasi Gawat Darurat dalam identifikasi dan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana lanjutan.
 - d. Instalasi Kebidanan dan Kandungan dalam pelaksanaan pelayanan KB Pasca Persalinan dan KB Pasca Keguguran.
 - e. Instalasi Bedah dalam pelaksanaan tindakan kontrasepsi mantap sesuai indikasi medis dan kewenangan klinis.
 - f. Instalasi Farmasi dalam perencanaan, penyediaan, penyimpanan, dan pemantauan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.
 - g. Instalasi Rekam Medis dalam pencatatan, pelaporan, pengumpulan, dan analisis data pelayanan keluarga berencana.
 - h. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan edukasi, penyuluhan, dan promosi kesehatan reproduksi.
 - i. Komite Mutu dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, indikator mutu, manajemen risiko, dan peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana.
 - j. Komite Medis, Komite Keperawatan, serta unit terkait lainnya sesuai kebutuhan pelayanan
- (4) Tim PKBRS wajib melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, rumah sakit jejaring, dan instansi terkait dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan keluarga berencana guna menjamin kesinambungan pelayanan pasien.

-
- (5) Tim PKBRS wajib menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan rapat insidental sesuai kebutuhan untuk membahas pelaksanaan program, capaian indikator, kendala pelayanan, serta rencana tindak lanjut perbaikan.

BAB III TATA LAKSANA

Pasal 4

- (1) Tim PKBRS menyusun program kerja tahunan yang memuat tujuan, sasaran, kegiatan, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana.
- (2) Tim PKBRS melakukan identifikasi sasaran pelayanan keluarga berencana yang meliputi pasien rawat jalan, rawat inap, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, pasien pasca keguguran, pasangan usia subur, dan kelompok lain yang memerlukan pelayanan keluarga berencana sesuai indikasi.
- (3) Pelayanan KB meliputi :
- a. konseling keluarga berencana
 - b. pelayanan kontrasepsi, pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP)
 - c. pelayanan KB Pasca Keguguran (KBPK)
 - d. pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), pelayanan kontrasepsi mantap
 - e. edukasi kesehatan reproduksi
 - f. sistem rujukan pelayanan KB

BAB IV MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan pelayanan keluarga berencana secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Monitoring dilaksanakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dengan kebijakan rumah sakit, standar profesi, standar prosedur operasional, program nasional keluarga berencana, dan standar akreditasi rumah sakit.
- (3) Tim PKBRS wajib melaksanakan evaluasi secara berkala paling sedikit satu kali setiap tiga bulan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, pencapaian sasaran, kendala, serta peluang perbaikan pelayanan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, peraturan direktur rumah sakit prima husada nomor tentang pedoman pelayanan PKBRS dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan direktur Rumah Sakit Prima Husada ini belaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA NOMOR **939.5/RSPHS/I-
PER/DIR/XI/2025**
TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PKBRS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan KB merupakan salah satu intervensi penurunan Angka Kematian Ibu melalui pencegahan kehamilan berisiko (kehamilan dengan 4 terlalu) dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dasar kebijakan pelayanan KB di Indonesia adalah UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana tujuan pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas dan Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Intervensi dilakukan melalui pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, alat dan obat perbekalan kesehatan, infrastruktur dan sarana pelayanan, regulasi manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan dan kemitraan serta penelitian dan pengembangan.

Undang-Undang RI No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 20 disebutkan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan. Apabila terjadi komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasyankes dasar (Puskesmas PONEK) maupun fasyankes lanjutan (RS PONEK). Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Nasional di Indonesia, menganut sistem “cafeteria” dengan menawarkan berbagai jenis kontrasepsi yang relatif aman dan efektif, dimana salah satunya adalah AKDR. Sesuai dengan HTA (*Health Technology Assesment*) Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Kemenkes tentang KB pada periode menyusui, salah satu upaya dalam meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang adalah ditujukan pada ibu pasca bersalin dengan menggunakan AKDR pasca persalinan dalam mengatur jarak kehamilan tanpa mempengaruhi produksi air susu ibu (ASI).

RS Prima Husada merupakan salah satu rumah sakit PONEK yang berada di Kabupaten Pasuruan, dimana menerima rujukan dari FKTP dan FKTRL untuk kasus-kasus kegawatan obstetri dan ginekologi, di rumah sakit ini juga melayani KB yang di kelola oleh Tim PKBRS yang secara kontinyu dan sinergis menjalankan aktivitas pelayanan di bidangnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Kerja Tim Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit disusun sebagai acuan bagi seluruh anggota Tim KB dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya secara terarah, terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan KB yang bermutu, aman, berkesinambungan, serta terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan reproduksi di rumah sakit.

2. Tujuan

A. Tujuan Umum

Pedoman kerja tim KB di fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan, sehingga pasien dapat memilih alat kontrasepsi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.

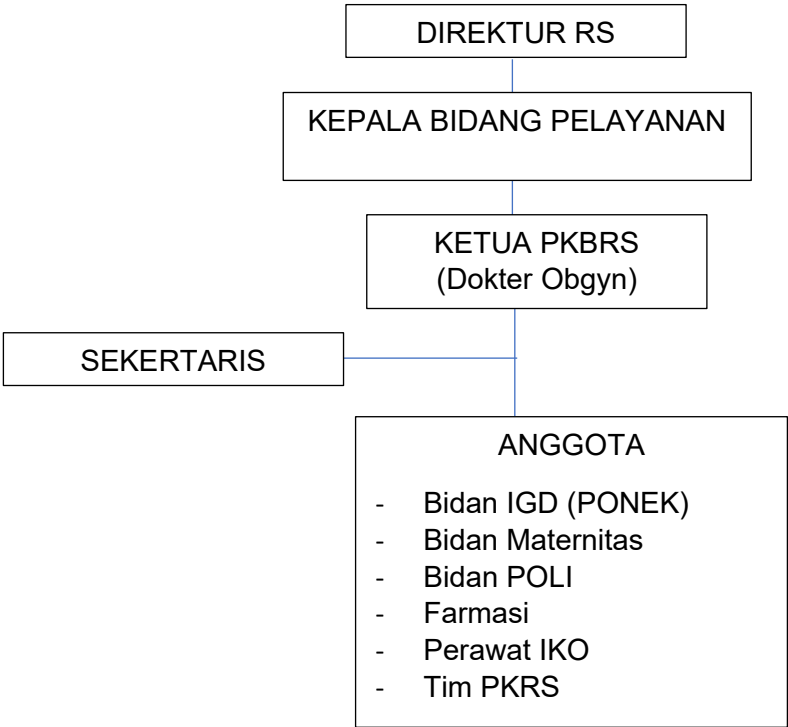
B. Tujuan Khusus

- a. Menjadi pedoman bagi Tim KB Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan KB.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar unit terkait dalam penyelenggaraan pelayanan KB.
- c. Menjamin terselenggaranya pelayanan konseling dan kontrasepsi sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional.
- d. Meningkatkan cakupan pelayanan KB, terutama KB pasca persalinan dan pasca keguguran.
- e. Menjamin pelaksanaan edukasi dan konseling kepada pasien serta keluarga terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- f. Meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan KB melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan.
- g. Menjamin terselenggaranya pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan KB secara tepat, lengkap, dan akurat.
- h. Mendukung pemenuhan standar akreditasi rumah sakit terkait pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- i. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan KB melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- j. Mendukung pencapaian indikator mutu pelayanan dan program kesehatan ibu serta kesehatan reproduksi di rumah sakit.

BAB II
PENGORGANISASIAN

2.1. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu Surat Keputusan Direktur RS nomor 883.3/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2022 tentang Penetapan Tim PKBRs



2.2. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Ketua TIM PKBRs
 - a. Nama Jabatan : Ketua
 - b. Persyaratan Jabatan minimal
 - 1) Sarjana Kesehatan diutamakan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
 - 2) Berpengalaman di bidang keluarga berencana minimal selama 3 tahun
 - 3) Mempunyai kemampuan dan ketrampilan komunikasi Informasi dan Edukasi.
 - 4) Mempunyai Sertifikat Diklat TCU atau diklat terkait pelayanan KB.
 - 5) Mampu, mau dan bertanggung jawab.
 - c. Uraian Tugas
 - 1) Membuat rencana program kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRs)
 - 2) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRs)
 - 3) Memimpin, mengkoordinir, dan mengevaluasi pelaksanaan operasional Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRs) secara efektif, efisien dan bermutu
 - 4) Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat, kebijakan, laporan, kebutuhan dan keluhan Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRs)
 - 5) Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRs)
 - 6) Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada dan kepanitiaan lainnya

-
- 7) Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - d. Tanggung jawab
 - 1) Bertanggung jawab pada Direktur RS Prima Husada
 - 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja dan Layanan KB di Rumah Sakit
 - 3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan KB
 - 4) Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan program pelayanan KB kepada Direktur RS Prima Husada.
 - 5) Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan program pelayanan KB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukorejo dan BKKBN
 - 6) Koordinasi dengan pihak eksternal atau dinas terkait.
 - e. Wewenang
 - 1) Menunjuk dan menetapkan sekretaris dan anggota Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - 2) Menentukan agenda setiap rapat Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - 3) Memerintahkan dan menugaskan staf dalam melaksanakan Program pelayanan kesehatan KB

2. Sekretaris Tim

- a. Uraian Tugas
 - 1) Membuat dan mendokumentasikan surat keluar
 - 2) Mengarsip surat masuk dan dokumen-dokumen
 - 3) Membantu dalam membuat program kerja
 - 4) Membantu dalam membuat pedoman kerja
 - 5) Membantu pembuatan spo terkait kegiatan program KB
 - 6) Membuat pemberitahuan undangan-undangan kepada semua anggota Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - 7) Mempersiapkan materi dan kelengkapan notulensi, absensi, konsumsi, ruangan
 - 8) Membantu pembuatan laporan triwulan program kerja tim
 - 9) Membantu meminta laporan kepada unit kerja terkait
 - 10) Menganalisis data bersama ketua dan anggota
 - 11) Mendokumentasikan hasil dari pelayanan KB
 - 12) Menjadi notulen di setiap kegiatan pertemuan Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - 13) Mengorganisir kebutuhan logistik
 - 14) Membantu berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal
- b. Tanggung Jawab
 - 1) Bertanggung jawab pada ketua tim
 - 2) Bertanggung jawab pada Direktur RS Prima Husada
- c. Wewenang
 - 1) Meminta laporan pelaksanaan program pelayanan KB di rumah sakit dari unit kerja terkait
 - 2) Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husadaterkait pelaksanaan program pelayanan KB di rumah sakit
 - 3) Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan KB di rumah sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada
 - 4) Melakukan komunikasi internal dan eksternal kepada unit kerja di lingkungan RS Prima Husada dan pihak luar melalui surat tertulis, email, dan telepon.

3. Poli Rawat Jalan

a. Uraian Tugas

1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna
2. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB
3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
4. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi saran pelayanan kesehatan lainnya
5. Melaksanakan system pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS

b. Tanggung Jawab

1. Bertanggungjawab pada ketua tim
2. Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan pelayanan kesehatan KB
3. Bertanggungjawab terhadap validasi data laporan
4. Bertanggungjawab dalam menyiapkan materi dan kevalidan isi materi KIE terhadap anggota yang memberikan materi.
5. Bertanggungjawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Investigasi pelayanan KB
6. Bertanggung jawab melakukan pencatatan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan KB di rawat jalan
7. Bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan KB ke Ketua Tim

c. Wewenang

1. Melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan investigasi terhadap pelayanan KB
2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan KB rumah sakit dari unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada

4. Bidan

a. Uraian Tugas

1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna
2. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB
3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
4. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi saran pelayanan kesehatan lainnya
5. Melaksanakan system pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKBRS.

b. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab pada ketua tim
2. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pelayanan kesehatan KB
3. Bertanggung jawab terhadap validasi data laporan
4. Bertanggung jawab dalam menyiapkan materi dan kevalidan isi materi KIE terhadap anggota yang memberikan materi.
5. Bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Investigasi pelayanan KB
6. Bertanggung jawab melakukan pencatatan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan KB di rawat inap
7. Bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan KB ke Ketua Tim

c. Wewenang

1. Melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan investigasi terhadap pelayanan KB
2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan KB rumah sakit dari unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada

5. Farmasi

a. Uraian Tugas

1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna
2. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB
3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
4. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi saran pelayanan kesehatan lainnya
5. Melaksanakan system pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan obat-obatan PKBRS

b. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab pada ketua tim
2. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pelayanan kesehatan KB
3. Bertanggung jawab terhadap validasi data laporan
4. Bertanggung jawab dalam menyiapkan materi dan kevalidan isi materi KIE terhadap anggota yang memberikan materi.
5. Bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Investigasi pelayanan KB
6. Bertanggung jawab melakukan pencatatan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan KB di Farmasi
7. Bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan KB ke Ketua Tim

c. Wewenang

1. Melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan investigasi terhadap pelayanan KB
2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan KB rumah sakit dari unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada

6. PKRS

a. Uraian Tugas

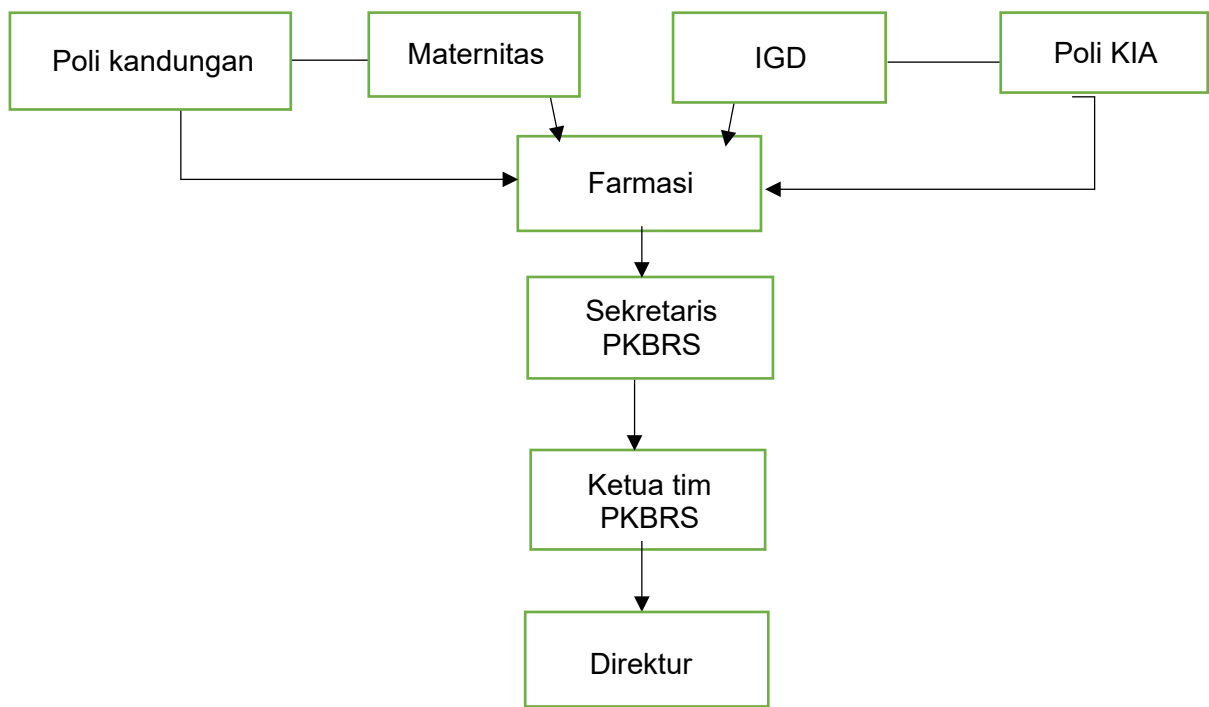
1. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna
2. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB
3. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
4. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan KB bagi saran pelayanan kesehatan lainnya

b. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab pada ketua tim
2. Bertanggung jawab terhadap promosi kesehatan terkait pelayanan KB di Rumah Sakit
3. Bertanggung jawab terhadap media promosi yang akan digunakan dalam penyampaian materi terkait KB dan pelayanannya

- 4. Bertanggungjawab dalam menyiapkan materi dan kevalidan isi materi KIE terhadap anggota yang memberikan materi.
 - 5. Bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan KB ke Ketua Tim
- c. Wewenang
- 1. Melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan investigasi terhadap pelayanan KB
 - 2. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan KB rumah sakit dari unit – unit kerja di lingkungan RS Prima Husada

2.3. TATA HUBUNGAN KERJA



BAB III

KEGIATAN DAN TATALAKSANA

Kegiatan Tim PKBRS di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan keluarga berencana Rumah Sakit harus dilaksanakan oleh tim PKBRS dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk menurunkan resiko AKI dan AKB karena faktor kelahiran, petugas kesehatan dari kejadian tindakan yang telah dilakukan kepada pasien, yang berbasis sayang ibu dan bayi.

3.1 Kriteria pendukung:

1. Adanya pedoman kerja tentang Pelayanan KBRS dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi tujuan, sasaran, program, kebijakan, struktur dan anggaran organisasi, uraian tugas Tim PKBRS.
2. Pelayanan KB dilaksanakan di Poli kandungan jika peserta KB ingin dilayani oleh dokter spesialis kandungan dan di Poli KIA jika peserta KB ingin dilayani oleh bidan.
3. Terdapat cakupan kegiatan tertulis mengenai program PKBRS memuat tentang kebijakan dan SPO pelayanan sesuai dengan standart dan SPO, yaitu:
 - a. Pelayanan KB dengan metode MOW
 - b. Pelayanan KB dengan metode AKDR
 - c. Pelayanan KB dengan metode implant
 - d. Pelayanan KB dengan metode suntik
 - e. Pelayanan KB dengan metode pil
 - f. Pelayanan KB dengan metode kondom
4. Pelayanan KB dipromosikan lewat penyuluhan dan edukasi kepada pasien rawat jalan serta rawat inap di Ruang bersalin.
5. Pelaksanaan program PKBRS dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala, yang dilaporkan oleh masing-masing anggota setiap bulannya, meliputi:
 - a. Jumlah sasaran KB
 - b. Jumlah keluar dan masuknya alat kontrasepsi yang digunakan
 - c. Kebijakan dan prosedur dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun untuk disempurnakan.

3.2 Prosedur Pelayanan

1. Pelayanan KB dirawat jalan dilakukan di Poli kandungan jika peserta KB menginginkan dilayani oleh dokter spesialis kandungan dan di Poli KIA jika menginginkan dilayani oleh bidan.
2. Pelayanan KB Pasca persalinan dan pasca keguguran dilakukan di Ruang Bersalin dan jika emergency dilakukan di UGD
3. Pelayanan KB pasca Persalinan juga bisa dilakukan di Ruang Operasi untuk tindakan MOW dan IUD pasca Plasenta.

3.3 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan setiap saat setiap ada tindakan KB yang dicatat pada lembar register dan dilaporkan setiap bulan kepada sekretaris KB.

3.4 Proses Pelaporan

1. Pelaporan dilaksanakan setiap bulan dan disetorkan ke BKKBN
2. Pelaporan dilaksanakan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direktur.

BAB IV

MONITORING DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

1. Monitoring dilaksanakan oleh Tim PKBRS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
2. Monitoring dapat dilakukan melalui:
 - a. Telaah rekam medis
 - b. Supervisi lapangan
 - c. Observasi pelaksanaan pelayanan
 - d. Audit dokumentasi
 - e. Wawancara petugas dan pasien
 - f. Analisis data pelayanan keluarga berencana
3. Aspek yang dimonitor meliputi:
 - a. Telaah rekam medis
 - b. Supervisi lapangan
 - c. Observasi pelaksanaan pelayanan
 - d. Audit dokumentasi
 - e. Wawancara petugas dan pasien
 - f. Analisis data pelayanan keluarga berencana.
4. Pelaksanaan konseling keluarga berencana
 - a. Pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP)
 - b. Pelayanan KB Pasca Keguguran (KBPK)
 - c. Pelayanan kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang
 - d. Kepatuhan petugas terhadap SPO
 - e. Kelengkapan pengisian rekam medis
 - f. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
 - g. Kompetensi petugas pelayanan
 - h. Pelaksanaan sistem rujukan
 - i. Pencapaian indikator mutu pelayanan keluarga berencana.
5. Hasil monitoring wajib didokumentasikan dalam formulir atau laporan monitoring yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.

4.2 PELAPORAN

1. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim PKBRS paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
2. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - a. Hasil monitoring rutin
 - b. Capaian indikator kinerja
 - c. Hasil audit pelayanan
 - d. Data pelaporan pelayanan keluarga berencana
 - e. Hasil survei kepuasan pasien
 - f. Hasil analisis insiden keselamatan pasien yang berkaitan dengan pelayanan keluarga berencana.

-
3. Evaluasi bertujuan untuk:
 - a. Menilai efektivitas pelaksanaan program
 - b. Mengetahui tingkat pencapaian target pelayanan
 - c. Mengidentifikasi akar masalah pelayanan
 - d. Menentukan tindakan korektif dan preventif
 - e. Menyusun rencana peningkatan mutu pelayanan.
 4. Evaluasi dilakukan melalui rapat Tim PKBRS yang melibatkan unit terkait sesuai kebutuhan.
 5. Hasil evaluasi wajib dituangkan dalam berita acara atau laporan evaluasi yang memuat:
 - a. Hasil capaian program;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Rekomendasi perbaikan;
 - d. Rencana tindak lanjut;
 - e. Penanggung jawab tindak lanjut;
 - f. Target waktu penyelesaian tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh anggota Tim PKBRS dan unit terkait dalam melaksanakan pelayanan keluarga berencana secara terintegrasi, efektif, efisien, aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh kegiatan pelayanan keluarga berencana di rumah sakit dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta standar akreditasi rumah sakit yang berlaku. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan edukasi, konseling, pelayanan kontrasepsi, monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana.

Seluruh pimpinan unit, tenaga kesehatan, dan pihak terkait wajib mendukung serta melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mencapai tujuan pelayanan keluarga berencana yang optimal dan mendukung program pembangunan kesehatan nasional.

Pedoman Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) ini akan dilakukan evaluasi dan peninjauan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan, standar akreditasi, maupun kebutuhan organisasi rumah sakit, sehingga tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan

Demikian Pedoman Kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana yang bermutu, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal, 1 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep